

Sa-Medication

把它和辅助心脏（AuxPump）合成一下，这样一个dump可以干两个lore

AuxPump 晨间校准

核心设计句

Sa 的药不是临时 buff，而是 AuxPump 每天早上写入身体配置时需要的校准剂。
他不是选择“吃不吃药”，而是在选择今天这具身体以哪种坏法运转。

玩家要懂的规则只有一句：

早上决定今天稳定还是跑热；出门后不能改。

内部逻辑是：

- Leash 不是速效镇静剂。
- 它需要在早晨低压力、低心率、低 Rev 状态下进入血液。
- AuxPump 会根据药物浓度、心率、血氧和神经噪声写入当天 profile。
- 一旦出门，profile 锁定。
- 白天中途补吃不会切换状态，只会造成配置冲突。
- 最坏结果是 AuxPump 进入限流，Sa 眩晕、手抖、黑屏、Revs 被锁。

所以玩家不会问：

“为什么我不对话前吃药，战斗前不吃？”

答案很简单：

因为这不是开关。是当天启动配置。

玩家 10 秒内看到的版本

早晨，公寓，镜子前。AuxPump 自检声。

辅助心脏校准等待确认。

今日配置将在离开住所后锁定。

选项一：

[吞下狗链]/Leash

冷静。迟钝。少听见一点... 但是今天能当个人。

选项二：

[开闸]/Raw

敏锐。快速。更容易失控。

确认后：

今日配置已锁定，直到下次睡眠。

这就够了。

玩家不用懂药理，也能懂规则。

玩家 2 分钟内明白的版本

第一次出现系统时，可以让 Ulises 说三句话：

“别把狗链当止痛片。它不是临时用的。”

“AuxPump 早上校准，白天锁死。你出门之后再补，只会限流。”

“上次你那么干，心脏停了八秒。”

这三句很好用：

- 说明它不是随时吃的药。
- 说明为什么每天早上决定。
- 说明违规后果很严重。
- 不进入 lore dump。

深层设定：只放在档案/医疗账单里

这部分可以存在，但不要主线强塞。

Leash 是一种长效神经降噪剂，会参与 AuxPump 的晨间灌注校准。它降低交感神经峰值、压低听觉增益、减少威胁误判，但会让 Sa 出现发冷、疲劳、反应迟钝和恶心。

未服用 Leash 时，AuxPump 会默认进入高增益补偿模式，允许更高的 Revs 峰值，但也会放大噪声输入、冲动反应和创伤性误判。

白天补服 Leash 被视为禁忌操作。因为一旦 Revs 超过基线，药物不会稳定系统，只会与高增益配置冲突，触发限流、眩晕、短暂断片或循环保护。

这段可以出现在：

- 医疗账单
- Ulises 的病例备注
- AuxPump 维护界面
- 黑市医生终端
- 玩家二周目可读资料

但主线 UI 不需要它。

以下是旧版Note，弃用

药物滥用：“功能性自毁”

现实中，像 Sa 这种患有创伤性脑损伤（TBI）、装有心脏辅助器、且伴随情绪失控的人，**100% 会药物滥用，但他不是为了“爽”，而是为了“能像个正常人一样行动”。**

- **药理冲突：**医生开的 TBI 镇静类药物会让他发冷、反胃、嗜睡。为了对抗这种嗜睡去查案，他必然会去黑市（比如找 Ulises）搞一些中枢神经兴奋剂或者过量的止痛药混着吃。
- **游戏设定的闭环：**这完美契合了你之前设定的“跑车与破车”的矛盾。他知道把兴奋剂和镇静剂混着吃会加速破坏自己的心脏，但他不在乎。他是在**透支生命来换取“功能性 (Functional)”**。

专属药理学：VTG 的黑市处方

Ulises 是个有底线的地下医生，他给的药是**“保命但折磨人”**的；而 Sa 自己搞来的药是**“好用但要命”**的。我们把它们跟现实中的药理对应起来：

【Ulises 开的药：理智的枷锁】

- **现实原型：**
 - **Beta受体阻滞剂（如普萘洛尔）：**用于控制心率、防止心脏病发作。现实副作用：手脚冰凉（发冷）、极度疲惫、ED（勃起障碍）。
 - **非典型抗精神病药/情绪稳定剂（如喹硫平）：**用于压制 TBI 带来的狂躁和冲动。现实副作用：视力模糊/重影、剥夺睡眠质量（虽然会困但睡不着）。
- **VTG 游戏内设定：**
 - **学名：**神经阻滞复合剂 (Neuro-Inhibitor Z)。
 - **街头俗称：**“狗链”(The Leash) 或“冰块”。
 - **表现：**蓝色的小药丸。Sa 吃完之后，手不抖了，脑子清醒了，但身体像泡在冰水里一样冷，下面也彻底成了太监。

【Sa 自己搞的黑市药：亡命徒的燃料】

- **现实原型：**
 - **合成安非他命 + 肾上腺素滴剂：**瞬间拉满心率，剥夺痛觉，极度专注。
- **VTG 游戏内设定：**
 - **学名：**高浓度促交感神经溶剂 (Sympathomimetic Overdrive)。
 - **街头俗称：**“搭火线”(Jumper Cables) 或“火花”。

- **表现：**类似哮喘喷雾器，或者直接滴在舌头下的滴剂。一旦吸入，瞳孔瞬间放大，药物副作用（发冷、眩晕）被短暂强行冲散，战斗力爆表，但药效过后心脏会像被人狠狠捏住一样剧痛。

3. PM 的系统设计裁决：千万不要随时吃药！

你担心 Scale（项目规模）控制不住是对的。在玩法上，**绝对不要把吃药做成背包里的消耗品（随时吃）！**

为什么？如果你让玩家可以随时吃药，玩家就会“功利化操作”：走到 NPC 面前，吃药，把对话选完；然后出门遇到怪，立刻断药，突突突。**这不仅毁了叙事的张力，而且会让你的代码逻辑极其复杂（你需要时刻监听他在什么状态下做了什么操作）。**

PM 的落地建议：采用“P3R/女神异闻录”式的【晨间宣誓（Morning Routine）】

把吃药做成每天/每个关卡开始前的**固定仪式**。

- **玩法循环：**每天开始，Sa 站在公寓那面脏兮兮的镜子前（或者在传送前往下一个区域前）。洗手台上放着一瓶药。
- **UI 弹出唯一选择：**
 - [吞下“狗链”] -> 激活 `IsMedicated = True`。本关卡对话畅通，超频战斗极短。
 - [把药冲进下水道 / 转身离开] -> 激活 `IsMedicated = False`。本关卡对话锁死，化身野兽。
- **为什么这么设计最好：**
 1. **极简的开发成本：**你只需要在 Level Load（关卡加载）时，给主角的 Boolean 赋一次值，整个关卡就不需要再做任何状态切换的逻辑判定。
 2. **极强的策略与悔恨感：**玩家一出门就无法回头了。如果他今天选了“吃药”，结果发现关卡里全是凶残的重甲敌人，打得极其痛苦，他就会后悔；如果他选了“不吃药”，……他 会感到深深的错愕和内疚。这正是你要的“玩家体会 Sa 的失控感”。

在战斗中，你现有的射击系统里，Sa 那种两枪秒人的“子弹时间（超频）”，在设定上其实就是他偷偷吸了一口黑市的“搭火线”。这是战斗内的高频操作，跟每天早上的长效处方药（狗链）不冲突。